

УДК:616.36:615.03

Б.Ж.Оразалин

Медицинский центр Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Оспанова

Опыт применения Тахо-Комба для достижения надежного гемостаза в оперативном лечении паразитарных кист печени

Аннотация. Существует много способов и методов оперативного лечения. Одним из самых грозных и вероятных осложнений при операциях по устранению кист и резекций печени является паренхиматозное кровотечение, возникшее как в момент самой операции, так и в раннем и отдаленном послеоперационных периодах. При применении «Тахокомба» достоверно уменьшается время, необходимое для достижения окончательного гемостаза раневой поверхности печени в 2,5 раза. Основной задачей при использовании ТахоКомба является достижение быстрого и надежного гемостаза в ходе резекции печени и профилактики паренхиматозных кровотечений и обильных кровопотерь.

Ключевые слова: паразитарные кисты печени, паренхиматозное кровотечение, ТахоКомб.

В общем количестве пролеченных больных в нашей клинике (Медицинский центр Западно-казахстанского государственного университета им. М. Оспанова, г. Актобе) пациенты с паразитарными поражениями печени составляют от 6,7 до 8,2 % (по данным 2006-2010г.г.). Подавляющее большинство этих больных страдали эхинококкозом (99,7%). Несмотря на проводимые мероприятия лечебно-профилактической направленности, тенденции к снижению эпидемиологии данного заболевания за последние годы, к нашему сожалению, не наблюдается. Возможно это связано с низкой гигиенической грамотностью населения, недостаточной работой ветеринарных служб, слабым контролем санитарно-эпидемиологического надзора. Так или иначе, но проблема паразитарных заболеваний, в их числе кистозных поражений печени, не теряет своей актуальности.

Лечение паразитарных кист печени – оперативное. Существует много способов и методов оперативного лечения, в их числе малоинвазивные, суть всех операций заключается в удалении кист с максимальным снижением риска обсеменения окружающих тканей и развития в дальнейшем рецидивов, а также сохранением функции пораженного органа (в данном случае печени). Выбор метода удаления кисты печени в целом зависит от ее размеров, локализации, степени пораженности (наличие множества кист), общего состояния больного и т. д.

Одним из самых грозных и вероятных осложнений при операциях по устранению кист и резекций печени является паренхиматозное кровотечение, возникшее как в момент самой операции, так и в раннем и отдаленном послеоперационных периодах. Анализируя данные по-

следних 5 лет, в нашей клинике кровотечения при удалении кист печени возникали редко: в 1,2% случаях во время операции, в 0,8% случаях в послеоперационном периоде (без летальности). Однако, следует отметить, что возникновение паренхиматозного кровотечения непосредственно в момент или после удаления эхинококковой кисты в значительной степени вызывает трудности при проведении операции, утяжеляет течение болезни, в небольшой степени способствует появлению в последующем нагноений, формированию абсцессов и других нежелательных исходов. Таким образом, важным в оперативном лечении паразитарных кист печени было и остается достижение стойкого гемостаза.

Эффективному гемостазу и формированию качественного тромба на участках удаленных кист печени способствует правильно исполненный капитонаж стенок кисты, но это не всегда представляется возможным, технически исполнить капитонаж в силу многих причин не всегда получается. Как средство гемостаза в оперативном лечении кист печени нами успешно применяется Тахокомб (НИКОМЕД, Австрия). Тахокомб как более усовершенствованный препарат с недавних пор пришел на смену простым коллагеновым гемостатическим губкам. Тахокомб – абсорбирующее гемостатическое средство для местного применения, который состоит из коллагеновой губки, покрытой с одной стороны компонентами фибринового клея (высококонцентрированного фибриногена и тромбина), способствующего свертыванию крови. При контакте с кровоточащей раной или другими жидкостями организма, содержащиеся в покрывающем слое факторы свертывания высвобождаются, и тромбин превращает фибриноген в фибрин. Перед наложением пластины Тахокомба раневая поверхность должна быть максимально вычищена (от крови, дезинфицирующих и других жидкостей). Сторону, помеченную желтым цветом наложить на раневую поверхность и прижимать в течение 3-5 минут. При нанесении пластины Тахокомба® на достаточно влажные раневые поверхности дополнительного увлажнения пластины не требуется. В случае применения Тахокомба® на сухие раневые поверхности, пластину следует увлажнить физиологическим раствором для достижения полного соединения с сухими участками раневой поверхности. Размер и количество пластин Тахокомба зависят от величины раневой поверхности. Края раны должны быть перекрыты пластиной на 1-2 см. Если для закрытия раневой поверхности требуется более одной пластины, то при наложении на рану их края должны перекрывать друг друга. Стерильными ножницами можно вырезать пластины требуемого размера

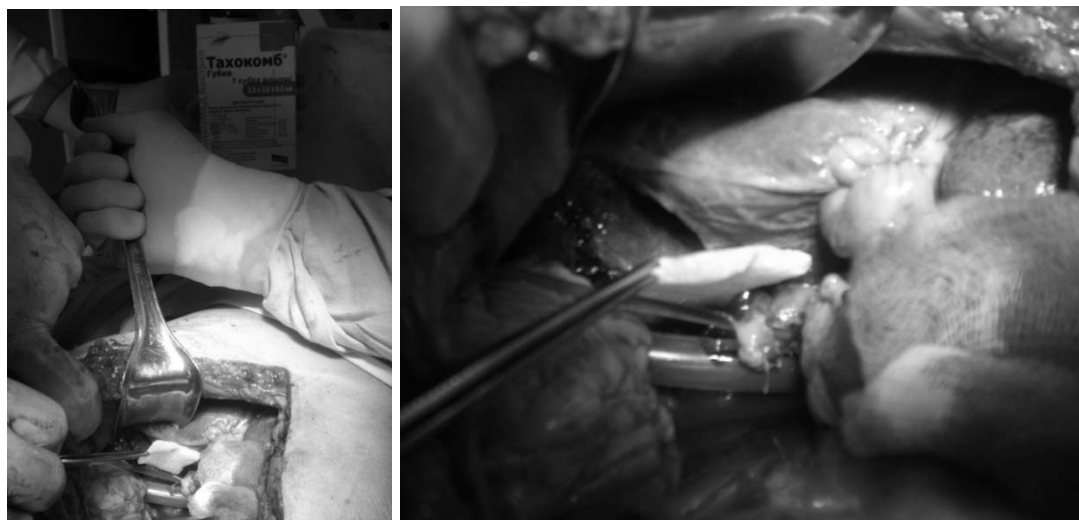


Рисунок – Использование пластины ТАХОКОМБа при резекции печени

как до, так и после наложения на раневую поверхность. Помимо физиологического эффекта гемостаза пластина обладает высокой адгезионной способностью, хорошо адаптируется как к ровным, так и бугристым раневым поверхностям, а механическая стабильность коллагена обеспечивает дополнительную защиту раневой поверхности. В организме компоненты пластины ТАХОКОМБ подвергаются ферментативному расщеплению в течение 3 - 6 недель. При применении «Тахокомба» достоверно уменьшается время, необходимое для достижения окончательного гемостаза раневой поверхности печени в 2,5 раза. Основной задачей при использовании ТахоКомба является достижение быстрого и надежного гемостаза в ходе резекции печени и профилактика паренхиматозных кровотечений и обильных кровопотерь.

Важным моментом в пользу применения Тахокомба на операциях по удалению кист печени, при наличии обширных паренхиматозных источниках кровотечения, является то обстоятельство, что другие привычные методы коагуляции: прошивание и перевязка сосудов, наложение зажимов, электрокоагуляция и т.д. менее предпочтительны в силу своей травматичности и опасности развития осложнений. «ТАХОКОМБ» как гемостатическое средство отвечает всем необходимым требованиям и как было уже отмечено выше широко применяется в нашей клинике на протяжении 5 последних лет. За это время он применен в 55 % оперативных вмешательств (123 операции) по удалению паразитарных кист печени. На практике мы неоднократно убедились в надежных гемостатических качествах Тахокомб. По данным опыта нашей клиники за это время, частота послеоперационных внутрибрюшных кровотечений у пациентов, которым выполнялись операции по удалению паразитарных кист печени составила-2%(7 операций). И ни в одном случае, где произошло кровотечение Тахокомб не применялся. По различным данным литературы интраоперационные кровотечения при операциях на печени встречаются от 7,4 до 8,9% случаев от общего количества операций. На наш взгляд снизить их количество можно применяя Тахокомб. Уменьшение объема интраоперационной кровопотери, чему в известной мере способствует применение Тахокомба, непосредственно влияет на снижение объема гемотрансфузии в послеоперационном периоде и во время операции, на профилактику послеоперационных осложнений. Все это влияет на течение болезни, при этом значительно снижаются сроки лечения в стационаре.

Наш положительный опыт применения Тахокомба

на операциях по удалению паразитарных кист печени позволяет рекомендовать его как более доступное и надежное средство местного гемостаза, когда применение других методов и способов по техническим и каким-либо причинам затруднительно или невозможно.

Список литературы

1. Барышев Б.А. Место Тахокомба среди традиционных способов местного гемостаза //Новые технологии в хирургической гепатологии.- СПб, 1995.-С. 134-140.
2. Вишневский В.А., Чжао А.Н., Назаренко Н.А. и др. Современные принципы техники оперативных вмешательств на печени // Анналы хир. гепатологии. -1996. -Т.1.-С. 15-23.
3. Горский В.А. Использование фибрин-коллагеновых пластин в абдоминальной хирургии //Вестник хирургии.- 2001.- Т.160, №2.-С.77-81
4. Северцев А.М.. Первый опыт использования раневого клеевого покрытия «ТахоКомб» в хирургии печени// Клинический вестник.-1995.-№3.-С.24-26.
5. Скипенко О.Г., Шатверян Г.А., Мовчун А.А., Ерамишанцев А.К. Применение раневого покрытия «Тахокомб» при хирургических вмешательствах на печени и поджелудочной железе //Хирургия.-1998.-№1.-С. 11-14.

Тұжырым

Б.Ж. Оразалин

Батыс Қазақстандағы мемлекеттік медицина университеті. Марата Оспанова ат.

Бауырдың паразитті кистасын оталық емнің Тахокомба қолдану тәжірибесі жетістігінің көрінісі гемостаза.

Көптеген оталық емдердің әдістері болады. Бауыр резекциясы және кистаны алып тастау кезіндегі отада көбінесе болатын асқын паренхиматозды кан кету. ота кезінде болатын, ерте және бөлек отадан кейінгі кезең.

«Тахокомба»ны қолданғанда уақыттың анық азаюы, бауырдың раневой бетінің ақырғы гемостаза табысы үшін қажетті. Тахокомбаны қолданудағы жетістік тез және сенімді гемостаз, бауырдың резекциясында және профилактикасында паренхиматозды кан кету, көп көлемде қан кету.

Түйінді сөздер: бауырдың паразиттік кистасы, паренхиматозды кан кету, ТахоКомб.

*Summary**B.J.Orazalin**Medical Center of West Kazakhstan State University.**Marat Ospanov*

Experience of using Tachocomb to achieve reliable hemostasis in the surgical treatment of parasitic cysts of the liver

Suschestvuet many ways and methods of surgical treatment, one of the most formidable and possible complications during operations to remove cysts and liver resections is parenchymal haemorrhage originating in the

time of the surgery, and in the early and late postoperative period.

In applying the "Tachocomb" significantly reduces the time required to reach a final hemostatic wound surface of the liver 2.5 times. The main objective of using Tachocomb is to achieve fast and reliable hemostasis during liver resection and prevention of parenchymal bleeding and heavy blood loss.

Keywords: parasitic cysts of the liver, parenchymal hemorrhage, TachoComb.